

Не просто накормить — материал к сессии

Кому: участнику дискуссии — унести в регион. **За сколько:** 3 минуты, один взгляд на столе. **После:** знать шесть вопросов, минимальную безопасную модель и красные линии; куда писать.

Дискуссия «Организация питания: опыт реализации проектов» · 26.08.2026, 14:00–15:30 · площадка № 2 — ДСО «Тесовый берег». Модераторы: Чистяков Е. В. (Серафимовский, 223-ФЗ), Нурбаев Т. А. (Тесовый берег, 44-ФЗ).

Шесть вопросов дискуссии

1. Кто выбирает форму питания — проживающий социального дома или его руководитель?
2. Как формировать меню при жёстких нормативно-правовых и финансовых ограничениях?
3. Должно ли быть питание в социальных домах «лечебным»?
4. Как совместить «лечебное питание» и «вариативное меню», не ограничивая право на выбор?
5. Как соблюсти баланс между выбором недееспособного «что ему есть» и его медицинскими рекомендациями?
6. Как совместить качество продуктов и нормирование цен при планировании бюджета?

Минимальная безопасная модель (без второй кухни)

Два варианта блюда + журнал + пищевая карта. Шесть опор — если хоть одна не выполняется, начните с неё:

1. **Документы.** Положение о питании и журналы (пробы, бракераж, отказов, заказа) — в ритме смены.
2. **Клиника.** Таблица врача «лекарство × еда» на посту; список риска дисфагии у сиделки; **три отказа подряд → врач в тот же день.**
3. **Люди.** На каждого кормимого — конкретный помощник; еда не подаётся, пока помощь не готова.
4. **Голос жителя.** Остатки на тарелках разбирают; есть хотя бы один канал пожеланий.
5. **Замер.** Ночной интервал и отходы известны числом (цель интервала — ≤ 13 ч).
6. **Пары эквивалентов.** Гречка или рис, курица или индейка — сырьё то же, норматив на продукты не меняется.

Одна просьба к 26.08: не менять всё меню. Один обед, одно отделение, одна неделя замера → пилот на 90 дней с двумя безопасными вариантами и журналом фактического выбора.

Чего нельзя делать (красные линии)

- **Без врача:** ограничения рациона (включая «диабетический стол»), изменение текстур, протокол при дисфагии и свободной воде, действия при длительном отказе, режим при седации, энтеральное/зондовое и комфортное кормление, сдвиг времени еды у жителей на инсулине.
- **Без учредителя:** изменение продуктовой строки финансирования, штатного расписания (норма помощи за столом), аутсорсинг питания, официальный статус и публичность пилота.
- **Без правовой проверки:** формулировки о «согласии недееспособного» в локальных актах, обработка пищевых карт как персональных данных (152-ФЗ), ответы на запросы прокуратуры, конструкции, где учреждение одновременно опекун жителя.

Таблица «лекарство × еда» законна только с подписью врача. Кухня исполняет назначение, не ставит диагноз.

Санитарная норма — двойной режим (норма меняется через 5 дней после сессии)

до 31.08.2026 — СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 7.1.11 (≥ 3 приёма в день, диетическое по показаниям). С 01.09.2026 — СанПиН 2.3/2.4.4282-26, п. 56 подп. 11 (та же норма дословно), подп. 12–14, п. 62 (питьевой режим), раздел VII. Число вариантов блюда не ограничено ни в одной редакции. На проверку — папка

(положение, меню с вариантами, журналы, пищевые карты, согласование с учредителем), а не формула «запрета нет».

Контакты и полный текст

Полное методическое руководство и «Доклад» на 10–12 страниц — в репозитории материалов семинара. Автор: Чистяков Е. В., директор СПб ГАСУСОН «ДСО „Серафимовский“». Со-модератор: Нурбаев Т. А., директор СПб ГБУСОН «ДСО „Тесовый берег“».

Материал носит информационный характер и не заменяет юридического заключения, клинической рекомендации или финансового расчёта. Шаблоны локальных форм требуют адаптации. Данные сверены на 22.08.2026.